



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF
TAHUN 2025**

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 1202/I-PDM/SDM/XII/2025

Tentang
Pedoman Perencanaan Kebutuhan Staf

Penanggung Jawab :



(Susan Rahmawati, S. Sos)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan Oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Perencanaan Kebutuhan Staf dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Perencanaan Kebutuhan Staf ini, mutu sumber daya manusia di Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 31 Desember 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF

1. dr. Resti Lestantini, M. Kes
2. Susan Rahmawati, S. Sos
3. drg. Endy Wira Pradana, MMRS
4. Puput Sekar Nariratih, Amd. Keb
5. Dwi Novianti, Amd. AK., S. Kes
6. Nur Rizkiah Amalia

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

PERATURAN DIREKTUR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan..... 1

 1.3 Sasaran 2

 1.4 Ruang Lingkup 2

 1.5 Pengertian 2

BAB II PENETAPAN POLA KETENAGAAN 4

BAB III PEMUTAKHIRAN 7

BAB IV PENETAPAN JUMLAH STAF 8

BAB V PROSES REKRUTMEN 31

BAB VI PROSES SELEKSI 33

 6.1 Seleksi Berkas File Pelamar 33

 6.2 Pelaksanaan Seleksi..... 34

 6.3 Tahap Penilaian 35

BAB VII PENETAPAN KEMBALI 36

BAB VIII PENETAPAN ORIENTASI UMUM DAN ORIENTASI KHUSUS 37

 8.1 Orientasi Umum 37

 8.2 Orientasi Khusus 37

BAB X PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dasar Perhitungan Dalam Penetapan Kebutuhan Staf 3

Tabel 2 Jumlah Kebutuhan Staf 8

Tabel 3 Jumlah Kebutuhan Staf Dokter 21

Tabel 4 Ketentuan Pakaian Dalam Masa Orientasi Umum 37

Tabel 5 Ketentuan Pakaian Dalam Masa Orientasi Khusus..... 38

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 1202/I-PDM/SDM/XII/2025**

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit Prima Husada diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 - b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 062.1/I-PER/DIR/I/2018 tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Staf sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Staf.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
 5. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF**

BAB I

PENETAPAN POLA KETENAGAAN

Pasal 1

Rumah Sakit menetapkan perencanaan kebutuhan staf rumah sakit yang berdasar atas perencanaan strategis dan perencanaan tahunan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit

Pasal 2

Rumah Sakit menetapkan prosedur tentang pola ketenagaan dan kebutuhan jumlah staf sesuai dengan yang dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan staf, panduan penempatan dan penempatan kembali staf.

BAB II PEMUTAKHIRAN

Pasal 3

Rumah sakit menetapkan pemutakhiran terus menerus pola ketenagaan

BAB III PENETAPAN JUMLAH STAF

Pasal 4

Rumah sakit menetapkan jumlah staf rumah sakit dengan mempertimbangkan misi rumah sakit, keragaman pasien, jenis pelayanan, dan teknologi yang digunakan dalam asuhan pasien.

BAB IV PROSES REKRUTMEN

Pasal 5

Rumah sakit menetapkan proses rekrutmen staf

BAB V PROSES SELEKSI

Pasal 6

Rumah sakit menetapkan proses seleksi untuk memastikan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi staf klinis sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pasal 7

Rumah sakit menetapkan proses seleksi untuk memastikan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi staf nonklinis sesuai dengan kebutuhan rumah sakit

Pasal 6

Rumah sakit menetapkan pelatihan teknik resusitasi jantung paru tingkat dasar pada seluruh staf dan tingkat lanjut bagi staf yang ditentukan oleh rumah sakit.

BAB VI PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 8

Rumah sakit menetapkan pengaturan penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf termasuk mempertimbangkan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama staf.

BAB VII PENETAPAN ORIENTASI UMUM DAN KHUSUS

Pasal 9

Rumah sakit menetapkan orientasi umum dan khusus bagi staf klinis dan non klinis baru

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 31 Desember 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 1202/I-PDM/SDM/XII/2025
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN STAF

PEDOMAN PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber Daya Manusia atau yang sering disebut dengan Personalia adalah suatu bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan pemenuhan sumber daya manusia khususnya Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang sesuai dengan standar profesi dan mempunyai kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan. Seleksi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) tersebut harus dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan dari setiap Satuan Kerja yang ada di rumah sakit.

Untuk dapat menunjang pencapaian dalam hal pelayanan maka proses Manajemen Sumber Daya Manusia (Sumber Daya Manusia) diperlukan sebuah pedoman kerja sehingga didapatkan hasil yang baik dan bermutu. Pelayanan yang bermutu di rumah sakit akan membantu setiap staf untuk dapat berkarya sesuai dengan profesi, pendidikan serta kemampuan yang dimiliki, membantu proses pelayanan pada pasien di rumah sakit sehingga pasien yang datang berobat ke rumah sakit merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang berarti pula customer tersebut nantinya akan sebagai sarana dalam mempromosikan rumah sakit. Keuntungan lain jika pasien cepat sembuh adalah mereka dapat segera kembali mencari nafkah untuk diri dan keluarga.

Pelayanan untuk staf di rumah sakit ini dijalankan berpedoman kepada Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003.

Pendidikan atau pelatihan adalah alat untuk mengubah, maka untuk perubahan yang dapat dilakukan oleh perorangan, group dan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas jadi pelatihan sangat penting dalam rangka mengubah dari yang terlatih menjadi lebih mahir dan dari yang belum terlatih menjadi terlatih.

Dalam manajemen sumber daya manusia juga dibahas tentang pelatihan dan pengembangan sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu penunjang untuk mencapai mutu pelayanan suatu perusahaan menjadi lebih optimal.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Manajemen Perencanaan Kebutuhan Staf adalah digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit.

-
2. Tujuan
Pedoman Perencanaan Kebutuhan Staf bertujuan untuk:
 - a. Membantu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompeten untuk memberikan pelayanan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Rumah Sakit.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit.
 - c. Mengoptimalkan efisiensi staf Rumah Sakit.
 - d. Meningkatkan kualitas staf Rumah Sakit

1.3 SASARAN

- a. Tercapainya pemenuhan kebutuhan staf Rumah Sakit Prima Husada yang sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan pertimbangan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.
- b. Terwujudnya pelayanan pasien yang professional

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan Kebutuhan Staf yaitu:

- a. Penetapan pola ketenagaan
- b. Rekrutmen
- c. Seleksi
- d. Orientasi
- e. Pendidikan dan pelatihan staf

1.5 PENGERTIAN

1. SDM Kesehatan (Sumber Daya Manusia Kesehatan) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
3. Kegiatan Standar adalah satu satuan waktu (atau angka) yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesinya.
4. Standar Beban Kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh seseorang tenaga kesehatan profesional dalam satu tahun kerja sesuai dengan standar profesional dan telah memperhitungkan waktu libur, sakit, dll.
5. Daftar Susunan Pegawai adalah jumlah pegawai yang tersusun dalam jabatan dan pangkat dan kurun waktu tertentu yang diperlukan oleh organisasi untuk melaksanakan fungsinya.
6. Analisa Beban Kerja adalah upaya menghitung beban kerja pada satuan kerja dengan cara menjumlah semua beban kerja dan selanjutnya membagi dengan kapasitas kerja perorangan persatuan waktu.
7. Beban Kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam satu tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan.
8. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Perencanaan Skenario adalah suatu perencanaan yang dikaitkan dengan keadaan masa depan (jangka menengah/panjang) yang mungkin terjadi.
10. WISN (Work Load Indicator Staff Need) adalah indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana kesehatan berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi/relokasi akan lebih mudah dan rasional.

-
11. Pola Ketenagaan adalah perencanaan kebutuhan staf dalam menghitung jumlah staf yang dibutuhkan rumah sakit dengan mempertimbangkan misi rumah sakit, keragaman pasien, layanan diagnostik dan klinis yang disediakan rumah sakit, volume pasien rawat inap dan rawat jalan, teknologi medis yang digunakan untuk pasien, serta ketentuan perundang-undangan terkait syarat Pendidikan, kompetensi, kewenangan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman untuk setiap anggota staf, serta ketentuan yang mengatur jumlah staf yang dibutuhkan di setiap unit layanan.
 12. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.
 13. Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup pemaduan kebutuhan-kebutuhan kerja pelamar dan organisasi. Dalam banyak departemen personalia, penarikan dan seleksi digabungkan dan disebut Employment function.
 14. Penempatan adalah kegiatan mengalokasikan staf pada posisi tertentu sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya guna mencapai tujuan. Penempatan juga dapat diartikan sebagai penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali staf pada tugas atau jabatan yang berbeda
 15. Orientasi adalah suatu program atau kegiatan untuk memperkenalkan staf baru tentang segala sesuatu mengenai institusi dan memahami tanggung jawab pekerjaan dan peran masing-masing untuk mencapai misi institusi

BAB II

PENETAPAN POLA KETENAGAAN

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain. Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian.

Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf.
- b. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama.
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana dan pelaksanaan strategi dimonitor secara berkelanjutan dan diperbaharui jika dibutuhkan. Dilakukan proses koordinasi oleh pimpinan unit layanan untuk update perencanaan staf ini.

Pola Ketenagaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dilakukan secara kolaborasi dengan perencanaan kebutuhan untuk menentukan jumlah kebutuhan, jenis serta kualifikasi staf yang diperlukan dalam sebuah unit kerja. Dan memberikan.

Jumlah staf rumah sakit ditetapkan berdasar atas kebutuhan tiap-tiap unit termasuk pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini daftar dasar perhitungan dalam penetapan kebutuhan staf yang dijadikan sebagai dasar pola ketenagaan.

Tabel 1. Dasar Perhitungan Dalam Penetapan Kebutuhan Staf

No	Unit/Instalasi	Dasar Perhitungan	Rumus Perhitungan
1	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Depkes 2005	$A = \frac{\sum \text{rata2 pasien perhari} \times \sum \text{waktu tindakan}}{\sum \text{jam kerja efektif perhari}}$ $B = \frac{\sum \text{hari minggu pertahun} + \text{cuti} + \text{hari besar}}{\sum \text{hari kerja efektif pertahun}}$ Koreksi 25% = (A+B) x 25% Rumus = A + (B x A) x koreksi 25%
2	Instalasi Rawat Jalan (IRJA)	Depkes 2005	$A = \frac{\sum \text{rata2 pasien perhari} \times \sum \text{waktu tindakan}}{\sum \text{jam kerja efektif perhari}}$ Koreksi 15% = A x 15% Rumus = A + koreksi 15%
3	Instalasi Rawat Inap (IRNA)	PMK No 56 Tahun 2014	Berdasarkan PMK no 56 tahun 2014 kebutuhan perawat adalah 2 perawat untuk 3 tempat tidur
4	Intensive Care Unit (ICU)	Depkes 2005	$\frac{\sum \text{jam perawatan} \times 52 \text{ minggu} \times 7 \text{ hari} \times \sum \text{TT} \times \text{BDR}}{40 \text{ minggu} \times 40 \text{ jam}} + \text{Koreksi 25\%}$

			Rumus = A + B
5	Instalasi Kamar Operasi (IKO)	Depkes 2005	$A = \frac{\sum \text{perawatan perhari} \times \sum \text{operasi} \times \sum \text{tim perawat}}{\sum \text{jam kerja efektif perhari}}$ $B = \frac{\sum \text{hari minggu pertahun} + \text{cuti} + \text{hari besar}}{\sum \text{hari kerja efektif pertahun}}$ Rumus = A + B
6	CSSD	Analisa Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$
7	Farmasi (Tenaga Tekhnis Kefarmasian)	- Permenkes 72 tahun 2016 - Permenkes 56 tahun 2014	Berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014, jumlah apoteker Rumah Sakit tipe C adalah 8 staf
8	Farmasi (Tenaga Tekhnis Kefarmasian)	- Permenkes 71 tahun 2016 - Permenkes 56 tahun 2014 - Analisa Beban Kerja	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$ Berdasarkan PMK no 56 tahun 2014 jumlah TTK Rumah sakit tipe C sebanyak 10 orang
9	Rekam Medis	Kepmenkes No 81 tahun 2004	(kuantitas kegiatan / standar beban kerja) + standar kelonggaran
10	Laboratorium	PMK No 411 tahun 2010	Berdasarkan PMK No 411 tahun 2010 jumlah tenaga laboratorium sebanyak 7 orang
11	Radiologi	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$
12	Gizi	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$
13	Dapur	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$
14	Laundry	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$
15	Keuangan dan Akuntansi	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$
16	Kamar Jenazah	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$
17	Fisioterapi	PMK 65 tahun	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$
18	SDM	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$
19	Keuangan dan Akuntansi	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum \text{waktu penyelesaian tugas}}{\sum \text{waktu kerja efektif}}$

20	Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum waktu penyelesaian tugas}{\sum waktu kerja efektif}$
21	SIMRS	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum waktu penyelesaian tugas}{\sum waktu kerja efektif}$
22	Rumah Tangga		
	Security	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum waktu penyelesaian tugas}{\sum waktu kerja efektif}$
	Cleaning Service	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum waktu penyelesaian tugas}{\sum waktu kerja efektif}$
	Gudang Umum	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum waktu penyelesaian tugas}{\sum waktu kerja efektif}$
	Driver	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum waktu penyelesaian tugas}{\sum waktu kerja efektif}$
23	Sekretariat	Analisis Beban Kerja Permendagri 12 tahun 2008	$\frac{\sum waktu penyelesaian tugas}{\sum waktu kerja efektif}$

BAB III

PEMUTAKHIRAN

Perencanaan kebutuhan staf rumah sakit terus menerus dimutakhirkan oleh pimpinan rumah sakit dengan menetapkan jumlah, jenis, kualifikasi yang meliputi pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- a. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan.
- b. Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Unit, SDM
- c. Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri
- d. Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan.

BAB IV

PENETAPAN JUMLAH STAF

Rumah sakit menetapkan jumlah staf rumah sakit berdasar atas kebutuhan tiap-tiap unit termasuk pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan misi rumah sakit, keragaman pasien, jenis pelayanan, dan teknologi yang digunakan dalam asuhan pasien.

Pimpinan unit layanan menetapkan persyaratan pendidikan, kompetensi, kewenangan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman staf untuk memenuhi kebutuhan memberikan asuhan kepada pasien.

Untuk menghitung jumlah staf yang dibutuhkan digunakan faktor sebagai berikut:

- a. Misi rumah sakit.
- b. Keragaman pasien yang harus dijalani, kompleksitas dan intensitas kebutuhan pasien.
- c. Layanan diagnostik dan klinis yang disediakan rumah sakit.
- d. Volume pasien rawat inap dan rawat jalan.
- e. Teknologi medis yang digunakan untuk pasien

Tabel 2. Jumlah Kebutuhan Staf

Jabatan	Kualifikasi	Σ Ketersediaan	Σ Standar Kebutuhan
Direktur Rumah Sakit Prima Husada	1. Kualifikasi Dokter 2. Pendidikan : a. S2 Magister Management b. Rumah Sakit 3. Pelatihan ACLS 4. Kompetensi a. Mempunyai pengalaman kerja di Rumah Sakit Minimal 2 Tahun	1	1
Kepala Bidang Pelayanan Medik	1. Kualifikasi Dokter / Perawat / Bidan 2. Pendidikan a. Dokter Umum/ Spesialis b. Perawat / Bidan 3. Pelatihan ACLS 4. Kompetensi a. Mempunyai Pengalaman Manajerial di Rumah Sakit Minimal 2 Tahun dan 5 tahun untuk non dokter b. Pengalaman Klinik di Layanan Kesehatan	1	1
Kepala Bidang Keperawatan	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1 Keperawatan 3. Pelatihan Manajemen Bangsal	0	1

	4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 3 tahun		
Kepala Instalasi Rawat Inap	1. Kualifikasi Dokter 2. Pendidikan Pendidikan Dokter Spesialis 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	1	1
Kepala Ruang Ina	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan a. BLS / ACLS b. Manajemen Bangsal c. PPGD 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 2 tahun	6	6
Perawat Pelaksana Ina	1. Kualifikasi a. Perawat b. Bidan 2. Pendidikan a. S1 Keperawatan b. DIII Keperawatan c. DIII Kebidanan 3. Pelatihan a. BLS b. BTLS c. ACLS d. PPGD 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun		
Ina 2C		6	6
Ina 3C		12	12
Ina 5C		7	7
Ina 234A		16	16
Ina 678A		21	21
Ina Maternitas		9	9
Kepala Instalasi Rawat Jalan	1. Kualifikasi Dokter 2. Pendidikan Pendidikan Dokter Spesialis 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	1	1

Kepala Ruang Irja	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan a. BLS / ACLS b. Manajemen Bangsal 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 2 tahun	1	1
Perawat Pelaksana Irja	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan a. S1 Keperawatan b. DIII Keperawatan c. S1 Perawat Gigi 3. Pelatihan a. BLS b. BTLS c. ACLS d. PPGD 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun	22	22
Bidan Pelaksana Irja	1. Kualifikasi Bidan 2. Pendidikan DIII Kebidanan 3. Pelatihan a. APN b. CTU 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kebidanan minimal 1 tahun	5	5
Fisioterapi dan Terapis Wicara	1. Kualifikasi a. Fisioterapis b. Terapis Wicara 2. Pendidikan a. DIII / DIV Fisioterapis b. DIII / DIV Terapis Wicara 3. Pelatihan - 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	5	5

Kepala Instalasi Gawat Darurat	1. Kualifikasi Dokter 2. Pendidikan Pendidikan Dokter Spesialis 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	1	1
Kepala Ruang IGD	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan a. BLS b. BTLS c. PPGD d. Manajemen Bangsal 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun	1	1
Dokter IGD	1. Kualifikasi Dokter 2. Pendidikan Dokter Umum 3. Pelatihan a. ACLS b. ATLS c. Hiperkes 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 1 tahun	9	9
Pelaksana IGD	1. Kualifikasi a. Perawat b. Bidan 2. Pendidikan a. S1 Keperawatan b. DIII Keperawatan c. DIII Kebidanan d. DIV Kebidanan 3. Pelatihan a. BTCLS / ACLS b. PPGD 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 1 tahun	23	23

Kepala Instalasi ICU	1. Kualifikasi Dokter Anestesi 2. Pendidikan Dokter Anestesi 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	1	1
Kepala Ruang ICU	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan a. BLS b. Manajemen Bangsal 5. Pelatihan ICU minimal 1 bulan 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun	1	1
Pelaksana ICU	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan ACLS 4. Pelatihan ICU minimal 1 bulan 5. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 1 tahun	9	9
Kepala Instalasi IKO	1. Kualifikasi Dokter Anestesi 2. Pendidikan Dokter Anestesi 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	1	1

Kepala Ruang IKO	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan - BLS - Instrumen - Manajemen Bangsal 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun	1	1
Penata Anestesi	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan - ACLS - Sertifikasi Anestesi 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 2 tahun	3	3
Instrumen	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan - BLS / ACLS - Sertifikasi Instrumen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 2 tahun	4	4
Onloop	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan BLS / ACLS 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun	3	3

Recovery Room	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan a. BLS / ACLS b. PPGD 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun	1	1
Kepala Bidang Penunjang Medik	1. Kualifikasi Sarjana 2. Pendidikan S1 Administrasi rumah sakit atau bidang pelayanan kesehatan 3. Pelatihan a. Manajemen Rumah Sakit b. Mutu dan Keselamatan Pasien 4. Kompetensi Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun	1	1
CSSD	1. Kualifikasi a. Perawat b. SMA / SMK 2. Pendidikan a. S1/DIII Keperawatan b. SMA 3. Pelatihan a. BHD b. Sterilisasi Dasar 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	3	3
Pelaksana Laundry	1. Kualifikasi Minimal SMA 2. Pendidikan SMA/Sederajat 3. Pelatihan PPI 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	5	5
Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit	1. Kualifikasi Apoteker 2. Pendidikan S1 Apoteker 3. Pelatihan a. Peracikan Obat b. Pengelolaan Sitostatika dan Sediaan IV 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	1	1

Apoteker Rawat Jalan	1. Kualifikasi Apoteker 2. Pendidikan S1 Apoteker 3. Pelatihan Peracikan Obat 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	5	5
Apoteker Rawat Inap	1. Kualifikasi Apoteker 2. Pendidikan S1 Apoteker 3. Pelatihan Peracikan Obat 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	5	5
Tenaga Vokasi Farmasi	1. Kualifikasi a. DIII/S1 Farmasi 2. Pendidikan a. DIII/S1 Farmasi 3. Pelatihan Penyiapan Obat 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	26	26
Admin Farmasi	1. Kualifikasi a. DIII/S1 Farmasi b. S1 Lainnya 2. Pendidikan a. S1 Lainnya 3. Pelatihan Tidak ada pelatihan khusus 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	1	1
Apoteker Gudang Farmasi	1. Kualifikasi Apoteker 2. Pendidikan S1 Apoteker 3. Pelatihan Peracikan Obat 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	1	1
Tenaga Vokasi Gudang Farmasi	1. Kualifikasi a. SMK Farmasi b. DIII/S1 Farmasi 2. Pendidikan a. SMK Farmasi b. DIII/S1 Farmasi 3. Pelatihan Penyiapan Obat 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	1	1

Kepala Instalasi Rekam Medis	1. Kualifikasi Perekam Medik 2. Pendidikan DIII Perekam Medik 3. Pelatihan Manajemen rumah sakit 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1
Perekam Medis	1. Kualifikasi Perekam Medik 2. Pendidikan DIII Perekam Medik 3. Pelatihan a. Filling dan Assembling b. Pengelolaan Rekam Medik 4. Kompetensi a. Menguasai ICD 10 b. Menguasai ICD 9 c. Menguasai grsfik Barber Jhonson	6	6
Pendaftaran	1. Kualifikasi a. Ahli Madya b. SMA 2. Pendidikan a. DIII RMIK b. SMA/SMK 3. Pelatihan Service Excellent 4. Kompetensi Pengalaman kerja 1 tahun di bidangnya	14	14
Kepala Instalasi Laboratorium	1. Kualifikasi Dokter Spesialis PK 2. Pendidikan Dokter Patologi klinik 3. Pelatihan Manajemen rumah sakit 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1
Kepala Unit Laboratorium	1. Kualifikasi Analisis 2. Pendidikan DIII Analisis Kesehatan 3. Pelatihan a. Plebotomi b. Bank Darah 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1

Analisis Kesehatan	1. Kualifikasi Analisis 2. Pendidikan DIII Analisis Kesehatan 3. Pelatihan Plebotomi 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	8	8
Kepala Instalasi Radiologi	1. Kualifikasi Dokter Spesialis Radiologi 2. Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi 3. Pelatihan ACLS 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1
Kepala Ruang Radiologi	1. Kualifikasi Radiografer 2. Pendidikan DIII Radiografer 3. Pelatihan Anatomi Tubuh 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1
Radiologi Pelaksana	1. Kualifikasi Radiografer 2. Pendidikan DIII Radiologi 3. Pelatihan Anatomi tubuh 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	5	5
Kepala Ruang Gizi	1. Kualifikasi Ahli Gizi 2. Pendidikan DIII Gizi 3. Pelatihan HACCP 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1
Pelaksana Gizi	1. Kualifikasi Ahli Gizi 2. Pendidikan DIII Gizi 3. Pelatihan HACCP 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	5	5

Juru Masak & Penyaji	1. Kualifikasi SMA / SMK 2. Pendidikan SMA / SMK 3. Pelatihan Penjamah Makanan 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	10	10
Kepala Bagian Umum	1. Kualifikasi Sarjana 2. Pendidikan S1 Semua Jurusan 3. Pelatihan Manajemen 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1
Kepala Ruang Asuransi Centre	1. Kualifikasi Ahli Madya 2. Pendidikan DIII RMIK 3. Pelatihan a. Filling b. Pengelolaan Rekam Medik 4. Kompetensi a. Pengalaman kerja 1 tahun di bidangnya b. Menguasai ICD 10 c. Menguasai ICD 9 d. Menguasai grafik Barber Jhonson	1	1
Coding	1. Kualifikasi Ahli Madya 2. Pendidikan DIII RMIK 3. Pelatihan a. Assembling dan Filling b. Pengelolaan Rekam Medik 4. Kompetensi a. Pengalaman kerja 1 tahun di bidangnya b. Menguasai ICD 10 c. Menguasai ICD 9 d. Menguasai grafik Barber Jhonson	7	7

Asuransi Jaminan Non BPJS Kesehatan	- Kualifikasi - Ahli Madya - SMK / SMA - Pendidikan - DIII RMIK - SMK / SMA - Pelatihan - Filling & Asembling - Pengelolaan Rekam Medik - Kompetensi - Pengalaman kerja 1 tahun di bidangnya - Menguasai ICD 10 - Menguasai ICD 9 - Menguasai grafik Barber Jhonson	2	2
Kasir	- Kualifikasi - S1 Ekonomi / Akuntansi - SMA / SMK - Pendidikan - S1 Ekonomi / Akuntansi - SMA / SMK - Pelatihan Manajemen keuangan - Kompetensi Pengalaman minimal 2 tahun dibidangnya	9	9
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga	- Kualifikasi Sarjana - Pendidikan S1 semua jurusan - Pelatihan Manajemen Rumah Sakit - Kompetensi Pengalaman minimal 2 tahun dibidangnya	1	1
Staf SDM	- Kualifikasi Manajemen SDM - Pendidikan S1 Psikologi atau S1 Lainnya - Pelatihan - - Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1

Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit	1. Kualifikasi SMK / S1 Teknisi 2. Pendidikan a. SMK b. D3 Elektromedik 3. Pelatihan Genset dan Kelistrikan 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1
Pelaksana IPSRS	1. Kualifikasi a. SMK b. D3 Elektromedis 2. Pendidikan SMA/Sederajat 3. Pelatihan Manajemen 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	5	5
Kepala IT SIMRS	1. Kualifikasi Sarjana 2. Pendidikan Sarjana Komunikasi/ IT 3. Pelatihan Manajemen SIMRS 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	1	1
Pelaksana IT SIMRS	1. Kualifikasi Sarjana 2. Pendidikan Sarjana Komunikasi/ IT 3. Pelatihan Manajemen SIMRS 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	2	2
Security	1. Kualifikasi SMA / SMK 2. Pendidikan SMA / SMK 3. Pelatihan Gada Pratama 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	12	12
Cleaning Service	1. Kualifikasi SMP / SMA 2. Pendidikan Minimal SMP atau SMA Sederajat 3. Pelatihan PPI dasar 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	40	40

Gudang Umum	1. Kualifikasi SMP / SMA 2. Pendidikan Minimal SMP atau SMA Sederajat 3. Pelatihan - 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	1	1
-------------	---	---	---

Tabel 3. Jumlah Kebutuhan Staf Dokter

Jabatan	Kualifikasi	Σ Ketersediaan	Σ Kebutuhan	Selisih (+/-)
Dokter Gigi Umum	a. Pendidikan Dokter gigi Umum b. Kompetensi Pengalaman pekerjaan 2 Tahun	1	0	0
Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia	a. Pendidikan Dokter gigi spesialis Ortodonsia b. Kompetensi Pengalaman pekerjaan 2 Tahun	1	1	0
Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	a. Pendidikan Dokter gigi spesialis Periodonsia b. Kompetensi Pengalaman pekerjaan 2 Tahun	1	1	0
Dokter Gigi Spesialis Gigi Anak	a. Pendidikan Dokter gigi spesialis Gigi Anak b. Kompetensi Pengalaman pekerjaan 2 Tahun	1	1	0
Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	a. Pendidikan Dokter gigi spesialis Gigi Anak b. Kompetensi Pengalaman pekerjaan 2 Tahun	1	1	0
Dokter Spesialis Patologi Klinik	a. Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik b. Kompetensi Pengalaman pekerjaan 2 Tahun	1	1	0

Dokter Spesialis Saraf	a. Pendidikan Dokter Spesialis Saraf b. Kompetensi Pengalaman pekerjaan 2 Tahun	4	4	0
Dokter Spesialis Bedah	a. Pendidikan umum Dokter Spesialis Bedah 1) DSTC 2) Laparoscopy b. Pengetahuan yang dimiliki Dokter Spesialis Bedah : 1) Pelayanan medis secara umum 2) Pelayanan bedah 3) Laparoscopy dasar 4) Laparoscopy lanjut 5) Perawatan pasca pembedahan c. Keterampilan yang dimiliki Dokter Spesialis Bedah : 1) Menggunakan alat-alat kedokteran 2) Melakukan operasi pembedahan 3) Melakukan perawatan pasca pembedahan 4) Mengoperasikan computer 5) Menggunakan alat kedokteran d. Pengalaman kerja menangani operasi pembedahan dan penanganan pasca operasi	4	4	0

Dokter Spesialis Orthopedi	a. Pendidikan : Dokter spesialis orthopaedi b. Pendidikan Khusus: 1) ATLS 2) DSTC 3) Laparoscopy 4) Pembedahan tulang c. Pengetahuan yang dimiliki Dokter Spesialis Orthopaedi : 1) Bedah tangan 2) Bedah bahu dan siku 3) Rekonstruksi sendi total 4) Orthopaedi anak 5) Bedah kaki dan pergelangan kaki 6) Bedah tulang belakang 7) Onkologi musculoskeletal 8) Bedah kedokteran olahraga 9) Trauma orthopaedi. d. Keterampilan yang dimiliki Dokter Spesialis Orthopaedi: 1) Menggunakan alat-alat kedokteran 2) Melakukan operasi bedah tulang 3) Melakukan perawatan pasca pembedahan tulang 4) Mengoperasikan komputer e. Pengalaman kerja menangani operasi bedah tulang dan penanganan pasca operasi.	3	3	0
----------------------------	--	---	---	---

Dokter Spesialis Urologi	a. Pendidikan Umum: Dokter Spesialis Urologi b. Pendidikan Khusus: 1) ATLS 2) DSTC 3) Laparoscopy 4) Pembedahan urologi c. Telah memenuhi persyaratan Kredensial Medis d. Mempunya wewenang sesuai yang tercantum dalam standart kompetensi Dokter Spesialis Urologi. e. Mempunyai sertifikat-sertifikat khusus yang mendukung terhadap profesinya.	2	2	0
Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi	a. Pendidikan Umum: Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi b. Pendidikan Khusus: 1) Tindakan praktik kebidanan 2) Penanganan praktik kebidanan terhadap pasien gawat darurat 3) Pengalaman kerja menangani pelayanan obs-gyn dan Memberikan konsultasi obgyn	3	3	0
Dokter Spesialis Anak	a. Pendidikan Umum Dokter Spesialis Anak b. Pendidikan khusus : 1) Psikologis anak 2) Terapi dan tindakan medis terhadap anak 3) Pengalaman kerja mampu memberikan pelayanan medis dan terapi kesehatan terhadap anak	3	3	0
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	a. Pendidikan Umum Dokter Spesialis Penyakit Dalam b. Pendidikan khusus : Penanganan kegawatdaruratan	5	5	0

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	a. Pendidikan Umum: Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. b. Pendidikan Khusus: 1) ACLS 2) Kateterisasi c. Pengalaman kerja mampu mendiagnosis dan memberikan pelayanan medis pasien penyakit jantung.	3	3	0
Dokter Spesialis Paru	a. Pendidikan Umum: Dokter spesialis paru b. Pendidikan Khusus: Tindakan medis kedaruratan c. Pengetahuan yang dimiliki Dokter Spesialis Paru : 1) Tindakan Medis Infeksi 2) Onkologi toraks 3) Asma dan PPOK 4) Pulmonologi Intervensi dan Gawat Darurat Napas 5) Faal Paru Klinik 6) Paru Kerja dan Lingkungan 7) Imunologik klinik 8) Operasi bedah torax / paru Keterampilan yang dimiliki Dokter Spesialis Paru : 1) Menangani kegawatdaruratan gangguan paru 2) Perawatan pasien gangguan paru 3) Tindakan operasi paru 4) Menggunakan alat-alat kedokteran e. Pengalaman kerja menangani pemeriksaan penyakit dan gangguan paru.	3	3	0

Dokter Spesialis Mata	a. Pendidikan Umum : Dokter Spesialis Mata b. Pendidikan Khusus : Penyakit mata dan pengobatannya c. Pengetahuan yang dimiliki Dokter Spesialis Mata : 1) Anatomi Mata 2) Diabetik Retinopati 3) Konjungtivitis Keratitis & Ulkus Kornea 5) Uveitis 6) Endoftalmitis 7) Pterygium 8) Retinoblastoma 9) Tumor Orbita 10) Strabismus 11) ARMD 12) Retinopati Prematuritas (ROP) 13) Retina Lepas d. Keterampilan yang dimiliki Dokter Spesialis Mata : 1) Diagnosis Penyakit Mata 2) Pemeriksaan Mata 3) Bedah/ operasi mata 4) Bahasa Inggris 5) Menggunakan Komputer 6) Menggunakan alat kedokteran e. Pengalaman kerja mendiagnosis dan memberikan pelayanan medis pasien penyakit jantung.	3	3	0
-----------------------	---	---	---	---

Dokter Spesialis THT-KL	a. Dokter Spesialis THT-KL telah menyelesaikan : 1) Pendidikan Umum : Dokter Spesialis THT-KL 2) Pendidikan Khusus : (a) Bedah mikro (b) Bedah endoscopy (c) Bronco ensophagotage (d) Oncotogo THT (e) Audilogi (f) Pluraris plastic (g) Scopi Immunologi b. Pengetahuan yang dimiliki Dokter Spesialis THT-KL : 1) Bedah Mikro THT 2) Bedah Endoscopy 3) Bronco esophagologis 4) Oncologi THT 5) Audilogi 6) Plastic rekonstruksi THT 7) Alergi iri/ imunologi c. Keterampilan yang dimiliki Dokter Spesialis THT-KL : 1) Menggunakan alat-alat kedokteran 2) Kemampuan melayani pasien gangguan mata 3) Menggunakan computer 4) Bahasa Inggris d. Pengalaman kerja mampu menangani gangguan dan penyakit THT, operasi THT dan penanganan pasca operasi.	2	2	0
-------------------------	--	---	---	---

Dokter Spesialis Jiwa	a. Dokter Spesialis Jiwa telah menyelesaikan: 1) Pendidikan Umum : Dokter Spesialis Jiwa 2) Pendidikan Khusus : (a) Pekerti (b) Psikoterap i (c) Tes Psikiater b. Pengetahuan yang dimiliki Dokter Spesialis Jiwa : 1) Mampu membuat tes psikologi terutama MMPI 2) Neuropsikiatri dan Psikometri 3) Psikoterapi 4) Psikiatri anak dan remaja 5) Psikiatri geriatric 6) Psikiatri adiksi 7) Consultation- Liaison Psychiatry 8) Psikiatri Forensik 9) Psikiatri Komunitas 10) Rehabilitasi Psikiatri 11) Trauma Psikososial c. Keterampilan yang dimiliki Dokter Spesialis Jiwa : 1) Melakukan psikoterapi 2) Menggunakan computer 3) Bahasa Inggris 4) Menggunakan alat kedokteran d. Pengalaman Kerja mendiagnosis penyebab dan menangani pasien gangguan jiwa dan depresi.	2	2	0
-----------------------	--	---	---	---

Dokter Spesialis Anestesi	a. Dokter Spesialis Anestesi telah menyelesaikan : 1) Pendidikan Umum : Dokter Spesialis Anestesi 2) Pendidikan Khusus : (a) Tindakan Diagnostik Elektif (b) Pemberian anestesi pada operasi darurat b. Pengetahuan yang dimiliki Dokter Spesialis Anestesi: 1) Perawatan Intensif/ ICU 2) Anestesi Bedah Jantung, torax dan kardiovaskular 3) Klinik nyeri 4) Regional analgesi 5) Anestesi bedah saraf 6) Anestesi pediatric 7) Anestesi bedah umum c. Keterampilan yang dimiliki Dokter Spesialis Anestesi: 1) Asuhan keperawatan pra-anestesi 2) Persiapan dan evaluasi pra- anestesi 3) Tindakan intra anestesi 4) Induksi, pemeliharaan dan emergence anestesi 5) Asuhan keperawatan pasca anestesi 6) Fungsi bantuan klinis dan perianestesi 7) Bahasa Inggris 8) Menggunakan computer 9) Menggunakan alat kedokteran d. Pengalaman kerja mampu melakukan tindakan anestesi pada pasien yang akan dioperasi dan mengevaluasi pasca tindakan anestesi.	3	3	0
---------------------------	---	---	---	---

Dokter Spesialis Radiologi	a. Pendidikan Umum: Dokter Spesialis Radiologi b. Pendidikan Khusus: 1) Tindakan medis kedaruratan 2) Radiologi c. Pengalaman kerja mampu melakukan pemeriksaan pelayanan radiologi dan menggunakan alat radiologi.	2	2	0
Dokter Umum IGD	a. Dokter umum b. Pendidikan Khusus: 1) Tindakan medis kedaruratan 2) Penanganan medis terhadap pasien 3) PPGD 4) BLS, ACLS, ATLS 5) Memiliki kemampuan mengenai pasien umum dan gawat darurat 6) Memiliki kemampuan menggunakan alat medik yang terkait dengan penanganan pasien gawat darurat.	9	9	0

BAB V

PROSES REKRUTMEN

Rekrutmen dilaksanakan secara terpusat, efisien dan terkoordinasi oleh Rumah Sakit dengan tujuan agar terlaksana proses rekrutmen yang seragam sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebutuhan rekrutmen berdasar atas rekomendasi jumlah dan kualifikasi staf yang dibutuhkan yang mengacu pada data pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf.

Perekrutan staf di Rumah sakit Prima Husada dilakukan selama 2 periode

1. Periode pertama bulan Januari
2. Periode kedua bulan Juni

Proses rekrutmen staf Rumah Sakit Prima Husada :

1. Tahap 1
 - a. Menentukan kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan.
 - b. Pola ketenagaan didasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebutuhan ketenagaan.
 - c. Kepala unit mengajukan form kebutuhan staf kepada SDM.
 - d. SDM mengelola pengajuan kebutuhan staf untuk selanjutnya di ajukan kepada Direktur Rumah sakit Prima Husada
 - e. Pengajuan kebutuhan staf disetujui bila telah mendapat persetujuan dari Direktur.

2. Tahap 2

Membuka info lowongan kerja

Rumah Sakit Prima Husada melakukan pemberitahuan lowongan kerja seragam melalui:

- a. Website resmi Rumah Sakit Prima Husada
- b. Instagram resmi Rumah Sakit Prima Husada

3. Tahap 3

- a. Melakukan seleksi file pelamar
- b. File yang tidak sesuai standar yang ditentukan akan disisihkan dan diletakkan berbeda dengan file yang sesuai standar.

- 1) Staf Medis

Seleksi staf keperawatan dilakukan oleh Komite Keperawatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh komite keperawatan, diantaranya:

- a) Kualifikasi
Dokter/ Dokter spesialis
- b) Pendidikan
 - (a) Sarjana kedokteran
 - (b) Dokter pendidikan spesialis
- c) Pelatihan
 - (a) BLS
 - (b) BTLS
 - (c) Manajemen Bangsal
- d) Kompetensi
 - (a) Penata Anestesi
 - (b) Instrumen
 - (c) NICU
 - (d) ICU
 - (e) PPGD

2) Staf Klinis Keperawatan

- a) Kualifikasi Perawat
- b) Pendidikan
 - (a) DIII Keperawatan
 - (b) DIV Keperawatan
 - (c) S1 Keperawatan
- c) Pelatihan
 - (a) BLS
 - (b) BTLS
 - (c) ACLS
 - (d) Manajemen bangsal
- d) Kompetensi
 - Sertifikasi khusus sesuai dengan unit kerjanya
 - (a) Penata Anestesi
 - (b) Instrumen
 - (c) NICU
 - (d) ICU
 - (e) PPGD

3) Staf Klinis lain

- a) Kualifikasi Ahli madya
- b) Pendidikan
 - (a) Ahli Madya sesuai bidangnya
 - (b) S1 sesuai bidangnya
- (c) Pelatihan
 - Pelatihan disesuaikan dengan bidangnya
- (d) Kompetensi
 - Sertifikasi khusus sesuai dengan bidangnya

4) Staf Nonklinis

Staf non klinis dilakukan sesuai kebutuhan unit

File pelamar baru akan digabungkan dengan file pelamar lama yang sudah diseleksi

a. Tahap 4

- 1) Pemanggilan pelamar dilakukan minimal 4 hari sebelum hari dilakukan seleksi dengan ketentuan:
- 2) Surat pemanggilan pelamar dilakukan melalui Whatsapp dan email sesuai dengan format yang sudah ditetapkan
- 3) Pelamar wajib membalas surat pemanggilan sebagai konfirmasi atas diterimanya surat panggilan seleksi.

b. Tahap Seleksi

Calon staf melakukan:

- 1) Uji kompetensi sesuai dengan profesi masing-masing.
- 2) Wawancara tentang status kepegawaiannya.
- 3) Wawancara tentang kompetensi dengan tim penguji.

Hasil dari uji kompetensi dan wawancara akan didiskusikan untuk selanjutnya diputuskan hasil dan dibuat dalam berita acaranya

BAB VI

PROSES SELEKSI

Seleksi dilaksanakan secara terpusat, efisien dan terkoordinasi oleh Rumah Sakit dengan tujuan agar terlaksana proses rekrutmen yang seragam sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebutuhan rekrutmen berdasar atas rekomendasi jumlah dan kualifikasi staf yang dibutuhkan yang mengacu pada data pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf

Anggota staf klinis yang kompeten direkrut melalui proses yang seragam dengan proses rekrutmen staf lainnya. Proses ini menjamin bahwa Pendidikan, kompetensi, kewenangan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman staf klinis pada awalnya dan seterusnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan agar dapat memenuhi kebutuhan pasien.

Staf nonklinis meliputi seluruh tenaga yang tidak memberikan asuhan pasien secara langsung. Pimpinan unit menjabarkan kualitas staf nonklinis yang diperlukan dan memastikan bahwa staf non klinis dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan penugasannya. Semua staf disupervisi dan dievaluasi berkala untuk menjamin kontinuitas kompetensi di posisinya.

Rumah sakit mencari staf yang kompeten dan memenuhi kualifikasi staf nonklinis. Staf nonklinis meliputi seluruh tenaga yang tidak memberikan asuhan pasien secara langsung. Staf secara berkala dilakukan evaluasi untuk memastikan terpeliharanya kompetensi pada jabatan.

Proses seleksi secara keseluruhan melibatkan Direktur PT Disa Prima Medika, Direktur Rumah Sakit, Kepala Bagian SDM maupun Kepala Instalasi terkait sebagai tim rekrutmen dan seleksi staf untuk mendapatkan staf yang berkualitas sesuai yang dibutuhkan sedangkan proses seleksi staf medis melibatkan Komite Medik, calon staf keperawatan melibatkan komite keperawatan dan calon staf profesi kesehatan lain serta calon staf non klinis melibatkan Sub Bag SDM sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Proses seleksi adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Berkas File Pelamar
Pelamar yang telah mengirimkan berkas lamarannya akan diseleksi oleh masing-masing tim sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan profesinya
 - 1) Staf Medis
Seleksi staf medis dilakukan oleh komite Medis sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh komite medis, diantaranya:
 - a. Kualifikasi
Dokter/ Dokter Spesialis
 - b. Pendidikan
 - (1) Sarjana Kedokteran
 - (2) Dokter pendidikan spesialis
 - c. Pelatihan
Pelatihan disesuaikan dengan spesialisnya yang menunjang kinerja dan kualitas pelayanan
 - d. Kompetensi
Memiliki sertifikasi khusus untuk menunjang pekerjaannya
 - 2) Staf Klinis
 - a) Staf Keperawatan

Seleksi staf keperawatan dilakukan oleh Komite Keperawatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh komite keperawatan, diantaranya:

- (1) Kualifikasi
Perawat
- (2) Pendidikan
 - (a) DIII Keperawatan
 - (b) DIV Keperawatan
 - (c) S1 Keperawatan
- (3) Pelatihan
 - (a) BLS
 - (b) BTLS
 - (c) ACLS
 - (d) Manajemen bangsal
- (4) Kompetensi
Memiliki sertifikasi khusus sesuai dengan unit kerjanya
 - (a) Penata Anestesi
 - (b) Instrumen
 - (c) NICU
 - (d) ICU
 - (e) PPGD

b) Staf Klinis Lain

Seleksi staf Klinis Lain dilakukan oleh komite Ad Hock sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Komite Ad Hock.

- (1) Kualifikasi
 - (a) Ahli Madya
 - (b) Sarjana
- (2) Pendidikan
 - (a) Ahli Madya sesuai bidangnya
 - (b) S1 Sesuai bidangnya
- (3) Pelatihan
Pelatihan disesuaikan dengan bidangnya
- (4) Kompetensi
Memiliki sertifikasi khusus sesuai dengan bidangnya

3) Staf Non Klinis

Seleksi staf non klinis dilakukan oleh SDM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Berkas yang sesuai kriteria akan diletakkan terpisah dengan berkas yang tidak sesuai kriteria dengan tujuan memudahkan proses seleksi.

Berkas yang sesuai kriteria akan dipisahkan berdasarkan profesi masing-masing. Seleksi akan memenuhi syarat bila jumlah pelamar 2 kali lipat dari jumlah kebutuhan tenaga.

2. Pelaksanaan Seleksi.

- a. Persiapkan presensi dengan no urut sesuai yang diberikan ke pelamar
- b. Persiapkan name tag untuk diberikan kepada pelamar
- c. Tanyakan kepada pelamar nomor seleksinya
- d. Name tag diberikan kepada pelamar sesuai nomor yang disebutkan
- e. Pelamar menandatangani presensi sesuai nomor urutnya
- f. Serahkan form data diri karyawan kepada pelamar untuk diisi
- g. Seluruh pelamar memasuki ruangan seleksi
- h. Peserta mengisi form biodata

-
3. Tahap Penilaian
 - a. Test tulis dilakukan serentak sesuai dengan bidang masing-masing pelamar
 - b. Test skill diberikan sesuai dengan bidang masing-masing pelamar
 - c. Wawancara kepeminatan oleh tim penguji sesuai dengan bidangnya

BAB VII

PENEMPATAN KEMBALI

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian.

Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf.
- b. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama.
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENETAPAN ORIENTASI UMUM DAN ORIENTASI KHUSUS

Keputusan untuk menempatkan seseorang sebagai staf rumah sakit dilakukan melalui berbagai proses. Agar dapat berperan dan berfungsi dengan baik, semua staf baru harus mengetahui dengan benar segala sesuatu tentang rumah sakit dan memahami tanggung jawab pekerjaan klinis atau nonklinis untuk mencapai misi rumah sakit. Hal ini dapat dicapai melalui orientasi umum dan orientasi khusus.

A. Orientasi Umum

Orientasi umum tentang rumah sakit, mutu, keselamatan pasien, serta pencegahan dan pengendalian infeksi.

- 1. SDM memberikan buku orientasi kepada seluruh staf baru
- 2. SDM membentuk TIM narasumber untuk memberikan materi kepada staf baru
- 3. Staf dijelaskan tentang materi orientasi serta hak dan kewajibannya selama orientasi hasil dari orientasi di evaluasi oleh SDM
- 4. Perlengkapan terkait acara pembekalan disiapkan oleh SDM
- 5. SDM mengevaluasi hasil pelaksanaan program.

Aturan yang berlaku dalam program orientasi umum adalah sebagai berikut :

- 1. Program orientasi dilakukan selama 7 hari.
- 2. Selama program orientasi umum tidak diperhitungkan sebagai gaji maupun uang transport.
- 3. Selama program orientasi staf baru belum mendapatkan tunjangan kesehatan.
- 4. Bila staf baru mengundurkan diri, maka wajib mengembalikan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit selama seleksi dan program orientasi.
- 5. Calon staf baru tidak mendapatkan konsumsi selama masa orientasi.
- 6. Orientasi dimulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
- 7. Sepatu Hitam
- 8. Ketentuan pakaian dalam masa orientasi :

Tabel 4. Ketentuan pakaian dalam masa orientasi umum

Jenis Staf	Pakaian
Staf Klinis	Bebas rapi, atasan berkerah dan menggunakan jas dokter
Staf Keperawatan	Atasan putih, bawah hitam
Staf Klinis Lain dan Nonklinis	Atasan putih, bawah hitam
Perempuan	Untuk muslim wajib berjilbab hitam

B. Orientasi Khusus

Orientasi khusus tentang unit kerja, uraian tugas, dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Demikian pula berlaku untuk staf kontrak, staf magang dan peserta didik.

Aturan yang berlaku dalam program orientasi khusus sebagai berikut :

- 1. Program orientasi dilakukan selama 3 bulan
- 2. Selama program orientasi khusus hanya mendapatkan gaji pokok dan uang

makan

- 3. Selama program orientasi karyawan mendapatkan tunjangan kesehatan, berupa berobat gratis rawat jalan di Klinik Mutiara Sehat
- 4. Bila karyawan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan di kontrak kerja
- 5. Ketentuan pakaian dalam masa orientasi

Tabel 5. Ketentuan pakaian dalam masa orientasi umum

Jenis Staf	Pakaian
Staf Klinis	Bebas rapi, atasan berkerah dan menggunakan jas dokter.
Staf Keperawatan	Atas putih, bawah putih
Staf Klinis lain dan Nonklinis	Atas putih, bawah hitam
Perempuan	Untuk muslim wajib berjilbab

- 6. Waktu orientasi khusus sesuai dengan jam kerja :
 - Shift 1 : 06.30-14.30
 - Shift 2 : 14.00-22.00
 - Shift 3 : 21.00-07.00
- 7. Mendapatkan jatah libur selama 4 hari selama 1 bulan.
- 8. Memakai sepatu hitam

BAB X

PENUTUP

Pedoman Perencanaan Kebutuhan Staf disusun dalam rangka memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam melakukan perencanaan kebutuhan staf yang bermutu, aman, efektif dengan mengutamakan keselamatan pasien. Oleh karena itu setiap rumah sakit diharapkan dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman ini dan dapat mengembangkannya sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 31 Desember 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes